RAPPORT D'AUDIT — SEPTEMBRE 2026

Audit Graphique & Expérience Utilisateur

Analyse de l'interface, du parcours et de l'accessibilité du site **addict-helper.ronanbch.com**, avec recommandations priorisées.

Site audité : addict-helper.ronanbch.com

Date de l'audit : 16 septembre 2026

Document 1 sur 2 — voir aussi l'audit Marketing & SEO

Sommaire

1. Résumé exécutif 3

2. Méthodologie 4

3. Vue d'ensemble de l'existant 4

4. Problèmes identifiés 5

5. Synthèse des priorités 9

6. Principes de la solution proposée 9

1. Résumé exécutif

Addict Helper est une application de suivi d'abstinence destinée à un public en situation de vulnérabilité. Le site actuel est fonctionnel, sobre et cohérent dans sa palette (vert profond, blanc, orange), mais il présente des lacunes importantes pour un produit de cette nature : **aucune preuve visuelle du produit**, **aucun élément de confiance ou de réassurance**, des **appels à l'action incohérents**, et des **défauts d'accessibilité** (notamment la déclaration de langue erronée, qui affecte aussi le référencement — voir l'audit SEO associé).

Sur un sujet aussi sensible que les addictions, l'expérience utilisateur est un facteur de conversion décisif : un visiteur hésitant doit être rassuré en quelques secondes sur la confidentialité, l'humanité du service et la réalité du produit. Ce rapport recense **11 problèmes** classés par gravité et propose des correctifs concrets, mis en œuvre dans la maquette HTML livrée avec ce document.

Tableau 1 — Répartition des problèmes par gravité

Gravité	Définition	Nombre
Critique	Bloque la conversion ou nuit fortement à la crédibilité	3
Majeur	Dégrade significativement l'expérience ou la confiance	4
Modéré	Frottement perceptible, facilement corrigeable	3
Mineur	Détail de finition	1

2. Méthodologie

L'audit a été réalisé le 16 septembre 2026 à partir des pages publiques du site (accueil, authentification, politique de confidentialité, robots.txt) consultées sur desktop (1920 × 1080). Chaque constat est appuyé par une capture d'écran et par l'examen du code HTML livré. L'évaluation s'appuie sur les bonnes pratiques reconnues du design d'interface (hiérarchie visuelle, cohérence des CTA, lisibilité, accessibilité RGAA) adaptées au contexte d'un service de santé grand public francophone.

> **PÉRIMÈTRE.** L'audit porte sur les pages publiques. Le tableau de bord connecté (/dashboard) étant protégé, ses écrans n'ont pas pu être examinés ; les recommandations qui suivent concernent donc l'environnement visible du visiteur non connecté.

3. Vue d'ensemble de l'existant

La page d'accueil suit une structure linéaire classique : hero pleine largeur sur fond vert, section « Comment ça marche » (3 étapes), section « Pourquoi Addict Helper » (6 atouts), section « Entourez-vous pour avancer » (aidants, proches, soignants), puis un footer minimal. La hiérarchie typographique est claire et le design reste épuré, ce qui constitue une base saine.

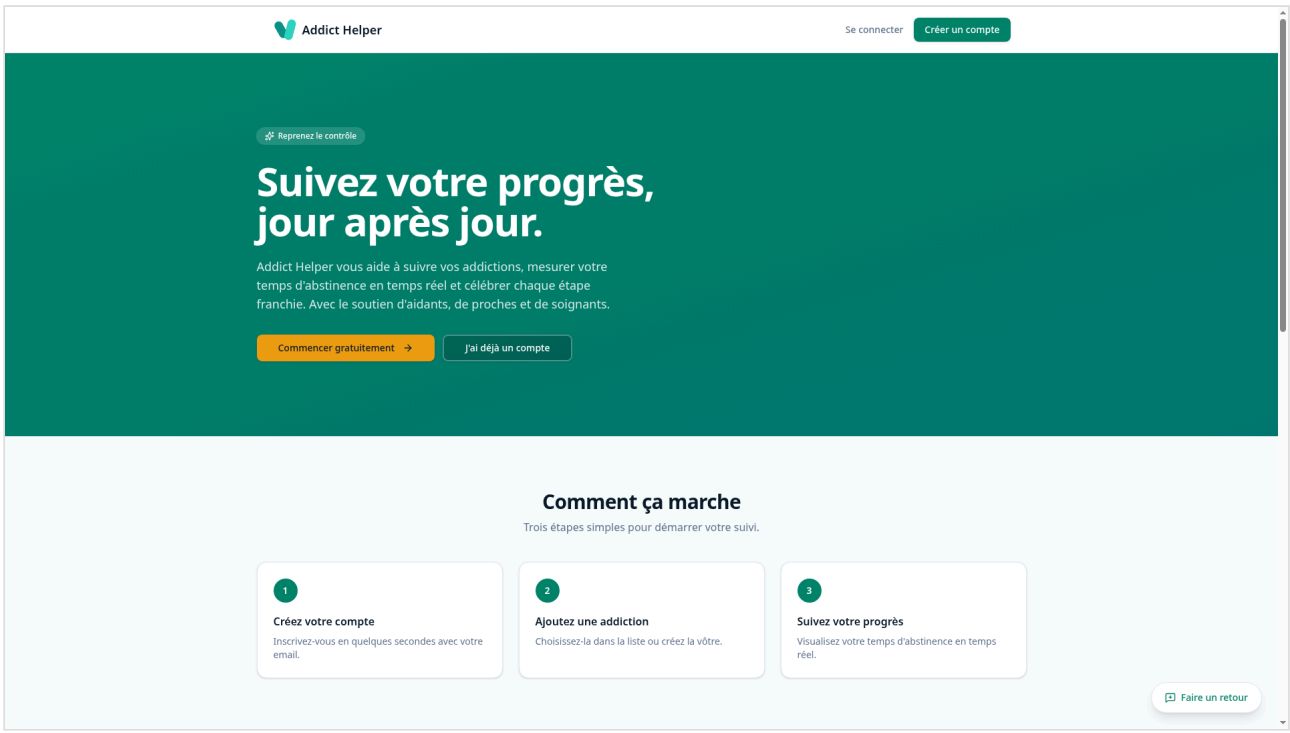


Figure 1 — Page d'accueil actuelle — hero sur fond vert uni, sans visuel produit

Cependant, l'ensemble manque de matière pour convaincre : aucune capture d'écran, aucune maquette, aucun témoignage, aucun chiffre. Le visiteur doit créer un compte pour découvrir ce que fait réellement l'application — une barrière élevée pour un produit dont la promesse repose sur la confiance.

4. Problèmes identifiés

P1. Aucune preuve visuelle du produit (Critique)

CONSTAT. Le hero et l'ensemble de la page ne montrent jamais l'interface de l'application (compteur d'abstinence en temps réel, étapes franchies, graphiques de progression). Le seul visuel du site est le logo.

IMPACT. Sur un marché où la concurrence (I Am Sober, Nomo, Tabac Info Service) montre systématiquement son produit, l'absence de démonstration crée un doute immédiat : « est-ce un vrai produit ? ». C'est le premier frein à l'inscription.

RECOMMANDATION. Ajouter une maquette d'écran (téléphone ou dashboard) animée ou statique dans le hero, montrant le compteur en temps réel, puis une galerie de 2–3 vues clés (suivis multiples, étapes, partage avec un proche).

P2. Incohérence totale des appels à l'action (Critique)

CONSTAT. Le hero propose « Commencer gratuitement » (bouton orange) et « J'ai déjà un compte » (bouton secondaire), tandis que les sections suivantes proposent « Créer mon compte » (bouton vert). Trois formulations différentes, deux couleurs de bouton principal, dont une (l'orange) n'apparaît nulle part ailleurs dans l'identité.

IMPACT. L'utilisateur ne sait pas laquelle des deux actions principales est la bonne ; la dispersion réduit le taux de clic et affaiblit la marque.

RECOMMANDATION. Une seule formulation primaire (« Commencer gratuitement » ou « Créer mon compte », pas les deux), une seule couleur de bouton primaire réutilisant l'accent de la marque, et un CTA secondaire unique « Se connecter ».

P3. Aucune réassurance sur un sujet sensible (Critique)

CONSTAT. Le site parle d'addictions et de soignants, mais ne rassure pas assez : pas de mention visible du chiffrement ou du respect du RGPD près des CTA, pas de avertissement « cet outil ne remplace pas un avis médical », et surtout aucune ressource d'aide directe (numéros nationaux, CSAPA) sur la page publique.

IMPACT. Pour un public fragile, l'absence de signaux de sécurité et d'échelle de secours fragilise la confiance et l'éthique du service. Un proche ou un soignant qui visite la page ne trouve aucune aide immédiate à transmettre.

RECOMMANDATION. Ajouter près des CTA une mention « Gratuit · Sans engagement · Vos données restent privées », un encart « Besoin d'aide maintenant ? » avec les numéros nationaux (Tabac Info Service 39 89, Drogues Info Service 0 800 23 13 13, Alcool Info Service 0 980 980 930) et un lien vers l'annuaire des CSAPA, ainsi qu'une clause de non-substitution médicale en bas de page.

P4. Aucune preuve sociale (Majeur)

CONSTAT. Pas de témoignages, pas de nombre d'utilisateurs, pas de note moyenne, pas de logos de partenaires ou de structures de santé.

IMPACT. Le marketing de la santé repose sur la preuve sociale : sans elle, l'inscription demande un saut de foi complet.

RECOMMANDATION. Introduire une section témoignages (avec prénom, parcours, durée d'abstinence) dès que les premiers utilisateurs sont disponibles, et des chiffres clés (« X suivis actifs », « X jours cumulés d'abstinence ») quand la volumétrie le permettra.

P5. Footer minimal et absence d'informations de service (Majeur)

CONSTAT. Le footer ne contient que « © 2026 Addict Helper » et un lien vers la politique de confidentialité. Il n'y a aucune page « À propos », aucun contact, aucune mention légale, aucun lien vers les ressources d'aide, aucune navigation.

IMPACT. Impossible de contacter l'équipe, de vérifier qui est derrière le service (indispensable pour un produit manipulant des données de santé), ou de retrouver les numéros d'urgence depuis le bas de page.

RECOMMANDATION. Structurer le footer en colonnes : À propos / Aide et ressources (numéros nationaux, CSAPA) / Légal (confidentialité, mentions légales, CGU) / Contact (e-mail).

P6. Bouton flottant ambigu « Faire un retour » (Majeur)

CONSTAT. Un bouton flottant permanent en bas à droite affiche « Faire un retour ». En français, cette formulation se comprend d'abord comme « revenir en arrière » ; sa fonction réelle (envoyer un avis) n'est pas claire. Il masque par ailleurs potentiellement du contenu et cohabite mal avec les CTA en bas de page, en particulier sur mobile.

IMPACT. Friction sémantique et risque de chevauchement sur petit écran ; peu de retours collectés.

RECOMMANDATION. Renommer « Donner un avis » ou « Nous écrire », n'apparaître qu'après un premier défilement, et décaler hors de la zone des CTA (ou le replacer dans le footer sur mobile).

P7. Formulaire d'authentification dépouillé (Majeur)

CONSTAT. La page de connexion est une carte blanche centrée sur fond blanc, sans contexte ni réassurance : pas d'aperçu du mot de passe, pas de connexion sociale, pas de rappel de la promesse de confidentialité, pas d'aide en cas de blocage au-delà de « Mot de passe oublié ? ».

IMPACT. Pour un sujet tabou, chaque friction du formulaire provoque des abandons ; l'écran ne dit rien de la sécurité des données saisies.

RECOMMANDATION. Ajouter un bas de formulaire réassurant (« Vos données sont chiffrées et ne sont jamais partagées »), un bouton d'affichage du mot de passe, et — côté inscription — un micro-copy qui valide l'approche progressive (« Commencez par un seul suivi, vous pourrez en ajouter d'autres ensuite »).

P8. Espacements verticaux excessifs et sections déséquilibrées (Modéré)

CONSTAT. De larges vides séparent les sections (jusqu'à ~200 px visibles entre les atouts et la section suivante), et le hero vert occupe une très grande hauteur sans contenu à droite du texte.

IMPACT. Sur les écrans 13–14 pouces, la page d'accueil entière tient difficilement à l'écran ; l'utilisateur scrolle longuement sans densité d'information.

RECOMMANDATION. Ramener les grands espacements à une échelle typographique cohérente (8 pt / 16 pt / 32 pt / 64 pt), et remplir la zone vide du hero par la maquette produit (voir P1).

P9. Défauts d'accessibilité (Modéré)

CONSTAT. Outre le `lang="en"` documenté dans l'audit SEO (qui fait lire la page avec une voix anglaise par les synthèses vocales), le logo porte un `alt` vide sans texte de remplacement, la navigation repose sur deux liens sans structure de menu, et les états de focus ne sont pas attestés visuellement.

IMPACT. Exclusion des utilisateurs de lecteurs d'écran et de navigation clavier — particulièrement problématique pour un public potentiellement en difficulté.

RECOMMANDATION. Corriger la langue en `lang="fr"`, structurer les landmarks (header, nav, main, footer), ajouter des états de focus visibles, et vérifier les contrastes (l'orange du CTA sur vert du hero doit être validé à 4,5:1 ; à défaut, utiliser le blanc sur vert).

P10. Répétition mécanique des sections (Modéré)

CONSTAT. La grille « 6 atouts » aligne des cartes au contenu quasi égal (« Simple », « Gratuit », « Motivant »…) : la redondance dilue le message au lieu de le renforcer. Aucune FAQ ne répond aux objections évidentes (Est-ce anonyme ? Que voient mes proches ? Que se passe-t-il si je rechute ?).

IMPACT. Le visiteur lit des promesses mais n'obtient pas de réponses ; les objections restent sans réponse au moment du clic.

RECOMMANDATION. Réduire les atouts à 4 arguments différenciés et développer une FAQ courte (5–7 questions) traitant confidentialité, rechute, rôle des proches et soignants.

P11. Identité graphique peu mémorable (Mineur)

CONSTAT. La palette (vert foncé, blanc, orange ponctuel) est correcte mais générique ; aucune illustration, texture ou motif de marque ne singularise le service.

RECOMMANDATION. Introduire un élément distinctif discret (motif de « jours », dégradé doux, illustration éditoriale autour du parcours), en conservant la sobriété adaptée au sujet.

5. Synthèse des priorités

Tableau 2 — Plan de correction recommandé, par ordre d'impact

Priorité	Problème	Correctif	Effort	Impact attendu
P1	P2 — CTA incohérents	Unifier formulation et couleur des CTA	Faible	Élevé
P2	P1 — Aucun visuel produit	Maquette d'écran dans le hero + 2–3 vues	Moyen	Élevé
P3	P3 — Manque de réassurance	Encart ressources d'aide + mentions confidentialité	Faible	Élevé
P4	P5 — Footer	Footer structuré (contact, légal, ressources)	Faible	Moyen
P5	P10 — FAQ et objections	Section FAQ (confidentialité, rechute, proches)	Moyen	Moyen
P6	P4 — Preuve sociale	Témoignages et chiffres dès que disponibles	Moyen	Élevé
P7	P6/P7/P8/P9	Bouton d'avis, formulaire, rythme vertical, accessibilité	Moyen	Moyen

6. Principes de la solution proposée

La maquette HTML livrée avec ce document applique l'ensemble des correctifs ci-dessus. Ses principes directeurs :

- **Réassurance avant conversion.** Chaque CTA est accompagné de mentions « Gratuit · Sans engagement · Données privées », et un encart « Besoin d'aide maintenant ? » affiche les numéros nationaux de santé publique (Tabac Info Service 39 89 ; Drogues Info Service 0 800 23 13 13 ; Alcool Info Service 0 980 980 930) en haut et en bas de page.
- **Montrer le produit.** Le hero présente une maquette d'interface en pur CSS (compteur d'abstinence en temps réel, étapes franchies) — sans image lourde, fidèle à l'esprit du produit.
- **Un seul appel à l'action.** « Commencer gratuitement » partout, dans une couleur unique issue de l'identité ; « Se connecter » reste secondaire.
- **Accessibilité native.** Page en français déclarée `lang="fr"`, structure sémantique (header, nav, main, footer), contrastes renforcés, focus visibles.
- **Sobre et humain.** Palette chaude épurée (crème, vert profond, accent corail discret), typographie éditoriale, aucun élément criard — le respect du sujet prime.

Ressources nationales citées : Tabac Info Service, 39 89 (gratuit, lun.–sam. 8 h–20 h) ; Drogues Info Service, 0 800 23 13 13 (gratuit et anonyme, 7 j/7, 8 h–2 h) ; Alcool Info Service, 0 980 980 930 (anonyme et non surtaxé, 7 j/7, 8 h–2 h). Sources : annuaire service-public.gouv.fr et sites officiels des services, vérifiées le 16 septembre 2026.